EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84523
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-14 16:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RAUL ENRIQUE ARAVENA ZAMORANO			**RUN**	: 13.601.234-7
F.Nac	: 26-09-1978	**Edad**	: 45 AÑOS, 7 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: VENUS 3			**Comuna**	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 987704656		
Fecha Ingreso	: 2024-05-12	**Fecha Egreso**	: 2024-05-14 16:32:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Encefalopatía Hepática GIII
DHC por OH | Child C 11 pts | Meld NA 29 pts
Hiponatremia leve
Anemia leve
HTP
OH activo
Tab: IPA 20, activo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Familiar de paciente refiere inicio de sintomatología 3 días previo ingreso, presentando compromiso de consciencia (somnolencia), asociado a desorientación en tiempo espacio y persona. Acorde a relato, refiere ausencia de deposiciones al menos desde hace 5 días. Antecedente de DHC por OH aparentemente con cese de hábito. Paciente refiere hábito presente, abundante (cerveza), previo a hospitalización. Refiere esta en controles poli gastro HSC Se rescata RNM de abdomen de enero 2024 con DHC y signos de HTP. LFH de 8 mm LR3. Ascitis leve.
Exámenes de laboratorio en urgencias evidencian elevación franca de BT (menor a controles previos), parámetros inflamatorios bajos, hiponatremia leve, amonio 162, HB 11.4, INR 2.0.
En vista de condiciones se decide ingreso a servicio.
Destaca persistencia en ausencia de deposiciones. Relata que es por decisión propia ante negación de defecar en cama. Se brindará permiso y asistencia a baño, en contexto de paciente orientado.
Luego de presentar abundantes deposiciones durante fin de semana paciente se encuentra hoy en mejores condiciones generales. Más conectado con medio, orientado en tiempo espacio y persona. Alimentandose por sus medios, y tolerando kine
Por tal motivo se decide su traslado a HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo en cama semisentado, levantar asistido

2. Regimen Liviano
3. Seguimiento Kine motora, mas fono si es posible
4. Lactulosa 20cc vo c8h para 2-3 deposiciones día
5. Furosemida 40mg vo c12h
6. Espironolactona 4 comp vo c12h
7. Propanolol 40mg vo c12h
8. Omeprazol 20mg 1 al dia vo
9. Metamizol 300mg 1 c/8hrs vo sos si dolor o fiebre
10. Control post alta Hodom poli Gastro Cae HSC

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO